

Le Nevrosi

Salute Mentale · Sessione 07 · 01.04.2026

Questa lezione è un viaggio tra passato e presente: scopriamo cosa sono le nevrosi, perché il termine è quasi sparito dai manuali ma il concetto è tutt'altro che morto, e ci addentriamo in due pilastri storici — il disturbo ossessivo-compulsivo e l'isteria. È un mondo che ci tocca da vicino, perché le nevrosi sono "emozioni normali, ma eccessive" (Faravelli, 2022).

Che cos'è la nevrosi? Definizione e storia

La **nevrosi** è storicamente definita come un disturbo psichico **senza causa organica**. La psicoanalisi la interpreta come l'espressione simbolica di un conflitto tra desiderio e regola, tra bisogno e possibilità — un conflitto che ha radici biografiche, culturali e sociali profonde.

Il termine fu introdotto verso la fine del 1700 dal medico scozzese **William Cullen**, per classificare tutte le malattie senza origine somatica che però si manifestavano in sedi organiche precise (nevrosi digestiva, cardiaca, uterina): sintomi reali, ma senza causa fisica identificabile.

Tre tappe storiche fondamentali

Protagonista	Periodo	Contributo
Philippe Pinel (psichiatra francese, 1745–1826)	Fine '700 / inizio '800	Evidenzia l'assenza di substrato organico; introduce il trattamento morale — cure non invasive, rispetto e dignità per il paziente
	'800	Studia l'isteria alla Salpêtrière a Parigi; stabilisce la natura puramente

Protagonista	Periodo	Contributo
Jean-Martin Charcot (neurologo francese, 1825–1893)		psicologica delle nevrosi; lavora con l'ipnosi
Sigmund Freud (neurologo austriaco, 1856–1939)	Fine '800 / primo '900	Illustra gli aspetti dinamici delle nevrosi: risultato di conflitti inconsci tra desideri repressi e le difese attivate per tenerli nascosti

Freud è stato allievo di Charcot, poi ha abbandonato l'ipnosi per sviluppare il **metodo delle libere associazioni** — la cura attraverso la parola.

Le nevrosi oggi: dove sono finite?

Nella **terza edizione del DSM** il termine "nevrosi" è stato abbandonato. Nel DSM-5-TR non compare più né nell'indice né nei titoli dei capitoli. Perché? La psichiatria statunitense ha "smantellato" una terminologia troppo legata alla corrente psicoanalitica, sostituendola con diagnosi più specifiche e osservabili.

Il prof. sottolinea (opinione): questa frammentazione privilegia la superficie rispetto alla profondità — è più facile descrivere "cosa si vede" che capire "cosa c'è sotto".

Il concetto nevrotico è oggi distribuito in diverse categorie del DSM-5-TR:

- **Disturbi d'ansia:** disturbo d'ansia generalizzato, fobia specifica, disturbo d'ansia sociale, disturbo di panico, agorafobia
- **Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati:** DOC, dismorfismo corporeo, disturbo da accumulo, tricotillomania, disturbo da escoriazione
- **Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti:** PTSD, disturbo da stress acuto
- **Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati:** disturbo da sintomi somatici, disturbo da ansia di malattia

Come effetto collaterale, questa frammentazione ha generato il concetto di **comorbidità** — la presenza contemporanea o successiva di più diagnosi nello stesso soggetto. Il rischio: trattare i disturbi come separati, senza chiedersi come siano connessi nella storia di vita della persona (Rossi Monti in Pewzner, 2002).

In alcuni testi il termine nevrosi sopravvive ancora in contrapposizione alla **psicosi**: nelle nevrosi il giudizio di realtà è mantenuto, nelle psicosi no.

La nevrosi come modo di vivere

La nevrosi non è una malattia in senso stretto — è piuttosto uno **scorretto modo di affrontare e risolvere la dinamica conflittuale interiore** che fa parte del quotidiano.

Pensa a qualcuno che, dopo un piccolo errore al lavoro, inizia subito a catastrofizzare: "Ho rovinato tutto, mi licenzieranno." O qualcuno che sente un lieve mal di gola e immagina subito una malattia grave. Questa amplificazione sproporzionata delle normali preoccupazioni è il cuore del funzionamento nevrotico.

Fraasi tipiche di chi soffre di un disturbo nevrotico (Sims, 2009): - *"Non ce la faccio più."* - *"Mi capita sempre così."* - *"Va sempre a finire così."* - *"Mi trovo sempre nella stessa condizione."*

È importante capire che **ognuno di noi può avere pensieri e comportamenti nevrotici** occasionalmente — la differenza con la patologia sta nella **durata, gravità e profondità** di quanto segue.

Tre criteri per riconoscere la patologia

Criterio	Significato
Durata	I sintomi persistono nel tempo (il DSM indica criteri specifici per ogni disturbo, es. almeno 6 mesi)
Gravità / Intensità	

Criterio	Significato
	I sintomi si presentano con intensità elevata, non una tantum, ma ripetutamente nel corso della giornata
Profondità / Compromissione	I sintomi compromettono il funzionamento in aree importanti: lavoro, relazioni, vita quotidiana

Questi tre criteri valgono in linea generale per tutti i disturbi psicopatologici.

Il sintomo egodistonico — nelle nevrosi ci si "sa"

Uno degli aspetti più importanti (probabile domanda d'esame, come sottolinea la docente): nelle nevrosi il sintomo è **egodistonico**.

Egodistonico significa che la persona è **consapevole** dell'irrazionalità dei propri sintomi. Sa che quello che fa non ha senso, lo vive come disturbante, come qualcosa di estraneo a sé. Questa consapevolezza porta la persona a **chiedere aiuto** più facilmente.

Al contrario, nei disturbi di personalità il sintomo è **egosintonico**: la persona considera i propri modi di essere come parte di sé, non li vive come problematici. Il risultato? Meno sofferenza soggettiva (o diversamente distribuita) e meno richiesta di aiuto — spesso sono i familiari o le terze parti a portare il paziente.

Esempio concreto dalla docente: chi soffre di DOC sa benissimo che i rituali sono irrazionali, ma non riesce a farne a meno. Chi invece ha un disturbo di personalità ossessivo-compulsivo pensa che il suo modo di organizzare il mondo sia semplicemente giusto — e non capisce perché gli altri abbiano problemi con questo.

La fenomenologia del disturbo nevrotico

La **fenomenologia** cerca di descrivere il disturbo dal punto di vista interno del paziente, non solo con una lista di sintomi. Aree colpite (Sims, 1999):

- **Esperienza del sé:** bassa autostima, cronica indecisione, senso di colpa e vergogna, perdita di fiducia in sé stessi. Si entra in un circolo di *demoralizzazione* — più ci si sente demoralizzati, più è difficile reagire positivamente.
- **Disturbi dell'umore:** ansia (elemento dominante), umore depresso, irritabilità. Il sonno è quasi sempre alterato: agitato, poco riposante, difficoltà ad addormentarsi.
- **Sintomi somatici:** disturbi motori, anestesi, ipocondria, dolori somatoformi (dolori fisici reali senza causa organica identificabile), dismorfofobia.
- **Esperienze relazionali:** tutte le aree della vita vengono colpite — lavoro, famiglia, relazione di coppia, relazioni sociali.

L'esame di realtà rimane integro (la persona capisce la realtà in cui vive), ma questo non le impedisce di viverla come **tirannica e immutabilmente inevitabile**.

La struttura nevrotica (Bergeret)

Il concetto di **struttura della personalità** è stato approfondito dallo psicoanalista francese **Jean Bergeret** (1923–2016). La struttura mentale è:

"L'organizzazione permanente più profonda dell'individuo, a partire dalla quale si organizzano sia le sistemazioni funzionali dette 'normali', sia le vicende patologiche." (Bergeret, 1996, p.3)

Bergeret distingue due **vere strutture** (più stabili): - **Struttura nevrotica** - **Struttura psicotica**

Nel mezzo si trovano le **organizzazioni limite** (stati limite / borderline), meno solide.

Punto cruciale: **avere una struttura nevrotica non significa essere malati**. Significa avere un certo modo di funzionare. La patologia emerge solo quando si verifica uno **scompenso** — una rottura dell'equilibrio causata da eventi stressanti, traumi, crisi.

Pensa alla struttura come al tipo di terreno su cui una pianta cresce: la struttura è il substrato. Normalmente, qualsiasi terreno funziona — la pianta cresce. Ma sotto stress idrico o alluvione (crisi), le vulnerabilità di quel terreno emergono. La struttura in sé non è patologia.

Caratteristiche della struttura nevrotica

Caratteristica	Descrizione
Istanza dominante	Super-Io (regole, morale, severo con sé stessi)
Natura dell'angoscia	Di castrazione (paura di perdere qualcosa di importante seguendo i propri desideri)
Natura del conflitto	Edipico: tra Super-Io (regole) ed Es (impulsi)
Livello di regressione	Parziale
Relazione oggettuale	Genitale: l'altro è visto come individuo reale, non solo oggetto di soddisfazione
Difesa principale	Rimozione (la realtà viene elaborata, trasformata, ma mai negata)

I sintomi sono **trasversali alle strutture**: ossessioni e compulsioni possono comparire sia in struttura nevrotica che psicotica. Per questo non si può fare diagnosi basandosi solo sui sintomi — serve uno sguardo più profondo, che consideri natura dell'angoscia, livello di regressione, modalità relazionale e tipo di conflitto.

Struttura e sviluppo evolutivo

Karl Abraham individua una **linea di divisione** (divided-line) tra fissazioni/regressioni psicotiche e nevrotiche: si situa tra il primo sotto-stadio anale di evacuazione (2–3 anni) e il secondo sotto-stadio anale di ritenzione (3–4 anni).

- **Infanzia:** prudenza — i sintomi nevrotici nel bambino non indicano necessariamente futura patologia.
- **Latenza:** periodo di relativa stabilità; si "rielaborano" le acquisizioni degli stadi precedenti.
- **Adolescenza:** ultimo momento possibile per un cambiamento di struttura (molto raro). È più facile passare da nevrotico a psicotico (in situazioni di crisi intensa) che il contrario. La diagnosi di struttura si pone solo in **età adulta** (circa dai 20–25 anni).

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)

Nel passato rappresentava, assieme alla nevrosi isterica, il **cuore delle nevrosi**. Caratteristica fondamentale: il **luogo del sintomo è il pensiero**.

Il DOC è caratterizzato da due sintomi predominanti:

Le ossessioni

Le **ossessioni** sono pensieri, idee, immagini o impulsi **non desiderati**, vissuti come ripugnanti, minacciosi, osceni, blasfemi o privi di senso. Sono incontrollabili, invadono la coscienza e sono incongruenti con il sistema di valori della persona.

Categorie più comuni (Castonguay e Oltmanns, 2023):

Categoria	Esempio
Contagio	Timore di sviluppare una malattia per aver usato fertilizzante da giardino

Categoria	Esempio
Responsabilità del danno	Dubbio di aver lasciato il forno acceso; timore di aver investito qualcuno in auto
Simmetria/ordine	Necessità che i libri siano in ordine alfabetico, altrimenti "capiterà qualcosa di brutto"
Sessuali	Impulso di baciare il proprio capo; dubbi sulla propria identità sessuale
Violenza/aggressione	Impulso di aggredire una persona cara o vulnerabile
Religione	Immagini blasfeme; dubbi sull'essere "abbastanza credenti"

Tre caratteristiche distinguono le ossessioni cliniche dalle semplici preoccupazioni:

1. Sono **non desiderate e incontrollabili** 2. Il contenuto è **incongruente** con i valori della persona 3. La persona **tenta di resistere** (senza riuscirci)

Le compulsioni

Le **compulsioni** sono rituali comportamentali o azioni mentali ripetitive, messe in atto per ridurre l'ansia generata dalle ossessioni.

Tipo	Esempio
Decontaminazione	Lavarsi le mani per 15–30 minuti seguendo un rituale preciso
Controllo	Verificare più volte serrature, finestre, interruttori
Ripetizione	Vestirsi e svestirsi più volte finché non "sembra giusto"
Rituali mentali	Ripetere preghiere, parole o contare per neutralizzare un pensiero

Le compulsioni **non sono agite per piacere**: chi le esegue ne trae temporaneamente **solievo** dall'ansia — e sollievo e piacere sono cose diverse.

Piacere = movimento *verso* qualcosa che dà gratificazione. Solievo = movimento di *allontanamento* da qualcosa di disagiata.

Il DSM-5-TR richiede che ossessioni/compulsioni consumino **più di 1 ora al giorno** o causino significativa compromissione funzionale. I sintomi non devono essere attribuibili a sostanze o condizioni mediche.

Elemento da non sottovalutare: l'**evitamento** — la persona evita persone, luoghi o situazioni che potrebbero innescare le ossessioni (es. evitare bagni pubblici per timore di contaminazione, evitare interazioni sociali per paura di fare del male ad altri).

Decorso e comorbidità

Senza trattamento, il DOC tende ad avere un **decorso cronico**, con oscillazioni della sintomatologia. I tassi di remissione spontanea sono bassi. Frequenti comorbidità con disturbi depressivi e altri disturbi d'ansia.

I meccanismi di difesa nel DOC

Nelle nevrosi si utilizzano **processi difensivi secondari** (meccanismi maturi, che distorcono la realtà in modo meno profondo rispetto ai primari).

Difesa	Come funziona nel DOC
Rimozione	Impulsi/desideri inaccettabili vengono eliminati dalla coscienza; riemergono sotto forma di ossessioni intrusive
Formazione reattiva	Un affetto negativo viene trasformato nel suo opposto (es. pensiero blasfemo → rituale di purificazione religiosa)
Spostamento	L'ansia generata dall'ossessione viene diretta verso un comportamento rituale più controllabile
Isolamento	La componente affettiva viene separata da quella cognitiva per ridurre l'angoscia

Difesa	Come funziona nel DOC
Annullamento retroattivo	Si mettono in atto comportamenti per "cancellare" simbolicamente pensieri o azioni precedenti

Fin qui ci sei? Bene — ora passiamo all'isteria, che è tutta un'altra storia, ma altrettanto affascinante.

La nevrosi isterica — dal passato ad oggi

La nevrosi isterica è la più antica delle sindromi psichiatriche conosciute.

Caratteristica fondamentale: il **luogo del sintomo è il corpo**.

Breve storia dell'isteria

Il termine deriva dal greco *hystéra* (utero). Le prime descrizioni risalgono al XX sec. a.C. — le manifestazioni venivano attribuite a movimenti dell'utero che si spostava comprimendo altri organi.

- **Ippocrate** (V sec. a.C.): prime descrizioni cliniche — difficoltà respiratorie, sensazione di "bolo esofageo".
- **Grecoi**: malattia tipica delle donne senza rapporti sessuali ("l'utero si prosciuga e cerca umidità").
- **Avvento del Cristianesimo**: le manifestazioni vengono associate a possessioni demoniache e stregoneria.
- **Fine '800 — Charcot**: all'Ospedale della Salpêtrière descrisse quattro fasi della crisi isterica: 1) fase epiletoide (contrazioni, sguardo fisso), 2) fase delle contorsioni (la famosa *posizione ad arco*), 3) fase allucinatoria, 4) delirio conclusivo. Lavorava con l'ipnosi per dimostrare la natura psicologica dei sintomi.
- **Freud**: abbandonò l'ipnosi per sviluppare le libere associazioni. Inizialmente attribuì l'isteria a traumi reali; in seguito capì che spesso si trattava di traumi nell'immaginario.

Manifestazioni storiche dell'isteria

Le crisi isteriche erano spettacolari, improvvise e transitorie: crisi espressive-emotive, tremori, fughe tipo panico, posizione ad arco. Si distinguevano dalle vere crisi epilettiche per: estrema **teatralità**, assenza di autolesioni, assenza di perdita di coscienza, conservazione della reazione pupillare alla luce. Frequenti anche disturbi della vista e dell'udito.

Il termine "isteria" è stato storicamente abusato — usato come insulto, come sinonimo di simulazione, o come diagnosi di ripiego quando non si trovava una causa organica.

Il meccanismo della conversione

Nella nevrosi isterica, il conflitto psichico **viene spostato sul corpo**: un conflitto tra desiderio e regola, che non riesce a essere elaborato psichicamente, trova espressione somatica. Il sintomo diventa un compromesso tra l'emergenza di una pulsione e la paura che questo avvenga.

La **struttura isterica** (Bergeret, 1996) è caratterizzata dalla forza della componente erotica e usa la **rimozione** come meccanismo difensivo prevalente. Si suddivide in due sotto-strutture:

- **Isterica di conversione**: il conflitto si esprime attraverso sintomi fisici (es. paralisi, anestesi, disturbi motori).
- **Isterica d'angoscia**: il sintomo centrale è la **fobia** — una paura angosciante scatenata da un oggetto o situazione non oggettivamente pericolosa. Quando la rimozione non basta, si ricorre allo **spostamento**: l'angoscia viene diretta verso un oggetto simbolico esterno. La fobia scompare quando l'oggetto o la situazione sparisce.

Come l'isteria è classificata oggi nel DSM-5-TR

Il termine "isteria" è scomparso, ma i suoi contenuti sono distribuiti in: - **Disturbi dissociativi**: disturbo dissociativo dell'identità, amnesia dissociativa - **Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati**: disturbo da sintomi somatici,

disturbo da ansia di malattia (ex-ipocondria), disturbo da sintomi neurologici funzionali (ex-disturbo di conversione)

La **fobia** è oggi classificata nei disturbi d'ansia come **fobia specifica** — ansia marcata verso un oggetto o situazione specifica (altezze, animali, volare, spazi aperti...), con paura sproporzionata rispetto al pericolo reale.

Il ruolo dell'operatore sociale

Come stare accanto a una persona con DOC? Il prof. Pezzoli ha dato indicazioni chiare:

1. **Nessun registro moralistico** — non giudicare il comportamento, anche se appare bizzarro.
2. **Non vietare le compulsioni** — aumenta l'ansia e peggiora la situazione.
3. **Lavorare sulla condizione che genera l'ansia**: se l'ambiente alimenta il disagio, lavorare sulla **familiarizzazione** e sul **senso di sicurezza**.
4. **L'operatore sociale** è custode delle condizioni socio-ambientali — creare ambienti più rassicuranti riduce già l'intensità della sintomatologia.

"Aumentare le quote di benessere contiene il male." — Prof. Pezzoli

Concetti chiave

Termine	Significato
Nevrosi	Disturbo psichico senza causa organica; conflitto inconscio tra desiderio e regola che produce sintomi
Egodistonico	Il paziente è consapevole dell'irrazionalità dei propri sintomi; li vive come disturbanti
Egosintonico	Il paziente vive i sintomi come parte di sé; non li riconosce come problematici

Termine	Significato
Struttura nevrotica	Organizzazione profonda della personalità: conflitto edipico, angoscia di castrazione, rimozione come difesa principale
Scompenso	Rottura dell'equilibrio strutturale che dà luogo alla patologia
Ossessioni	Pensieri/immagini/impulsi indesiderati, incontrollabili, incongruenti con i valori della persona
Compulsioni	Rituali comportamentali o mentali per ridurre l'ansia ossessiva; forniscono sollievo (non piacere)
Conversione	Trasferimento sul piano somatico di un conflitto psichico irrisolto
Fobia	Paura angosciante e sproporzionata verso un oggetto/situazione non oggettivamente pericoloso
Comorbilità	Presenza contemporanea o successiva di più diagnosi nello stesso soggetto
Rimozione	Meccanismo difensivo: impulsi/desideri inaccettabili vengono eliminati dalla coscienza
Formazione reattiva	Trasformazione di un affetto nel suo polo opposto per renderlo meno minaccioso
Spostamento	Redirezionamento di una pulsione/emozione dal suo oggetto originale a uno meno minaccioso
Isolamento	Separazione della componente affettiva da quella cognitiva di un'esperienza
Annullamento retroattivo	Comportamenti simbolici per "cancellare" pensieri/azioni precedenti

Collegamenti

- **Lezione precedente (emozioni):** La distinzione **piacere vs. sollievo** introdotta all'inizio è cruciale per capire le compulsioni — danno sollievo (allontanamento dal disagio), non piacere.
- **Lezione sui meccanismi di difesa:** Rimozione, formazione reattiva, spostamento, isolamento sono stati trattati in precedenza — qui vengono applicati specificamente alle nevrosi.
- **Prossime lezioni:** Disturbi di personalità (Elisa Milani) — si incontrerà il sintomo egosintonico. Psicosi — si vedrà come la struttura psicotica si differenzia da quella nevrotica.
- **Tema aperto:** Il ritiro sociale è trasversale (DOC, disturbi di personalità, psicosi) — non va mai interpretato da solo come diagnosi.